



Jornada para Entender o SUS

Sessão 1 - Financiamento do SUS

16 de Março de 2023

Análise de Conjuntura

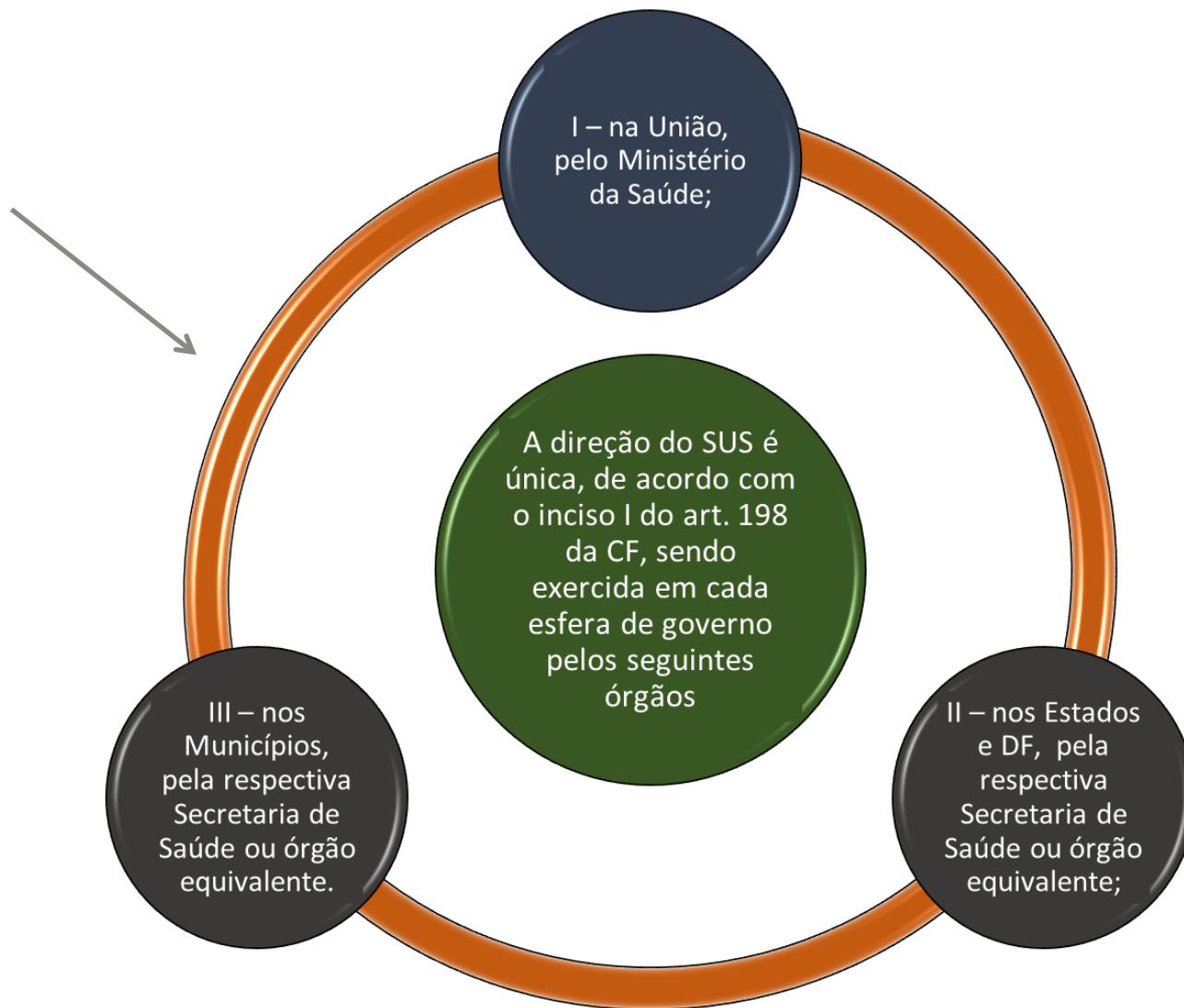
Crise Econômica - há nítida oscilação em torno da média dos níveis de negócios com forte impacto no PIB e no nível de emprego.

Crise Política - instabilidade na governança manifestada pelo desequilíbrio entre estado, sociedade e mercado.

Crise Fiscal - o que se recebe de imposto não dá mais para atender as demandas e gastos a serem quitados.

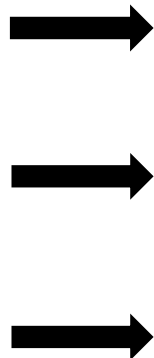
Responsabilidade pela Gestão do SUS

Art. 9.



Fluxo do Processo de Gestão em Saúde

Seguindo diretrizes das **Conferências de Saúde** sob orientação do **Conselho de Saúde** e de normas regulamentares normatizadoras, os gestores de saúde deverão organizar o planejamento das ações de saúde a serem executadas de forma ascendente e integrada, sob os respectivos níveis de responsabilidades.



Planejamento

Conhecimento do território e suas necessidades assistenciais de saúde



Plano de Saúde

Definição e priorização de objetivos e metas em um período anual



Programação Anual de Saúde

Definição das ações de saúde a serem executadas por meio de metas físicas e necessidades de recursos financeiros



Projeto de Lei Orçamentária Anual

Fluxo do Processo de Gestão em Saúde



Financiamento

União: EC 95/2021
15% RCL 2017 + IPCA ano a ano

Estados: LC 141/2012
mínimo 12% Recursos Próprios,
observado se o % estabelecido na
Constituição Estadual não for
superior

Municípios: LC 141/2012 mínimo
15% Recursos Próprios, observado
se o % estabelecido na Constituição
Municipal não for superior

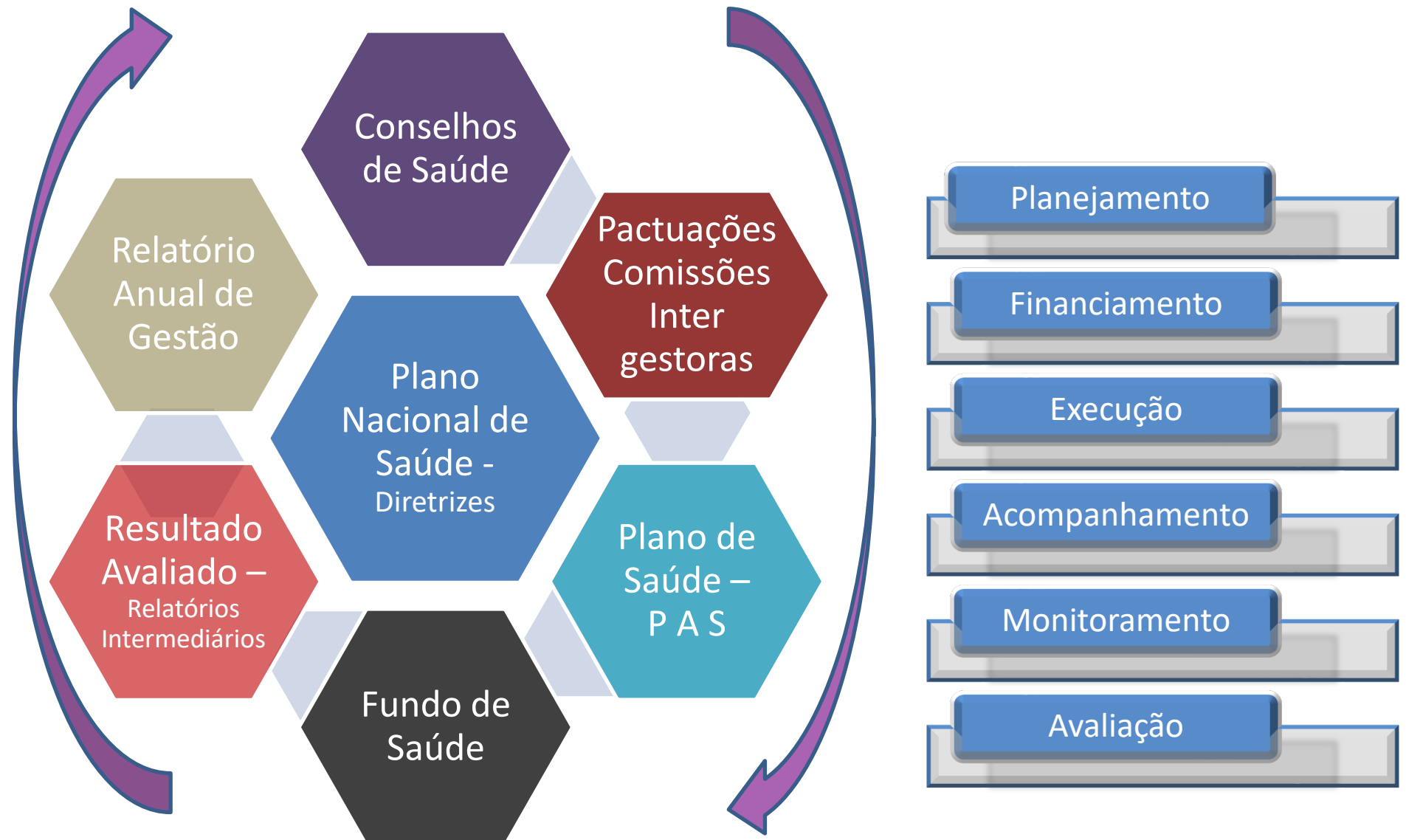
Operacionalização

Transferências de recursos *fundo a fundo* aos entes subnacionais em contas correntes específicas em instituições financeiras oficiais federais.

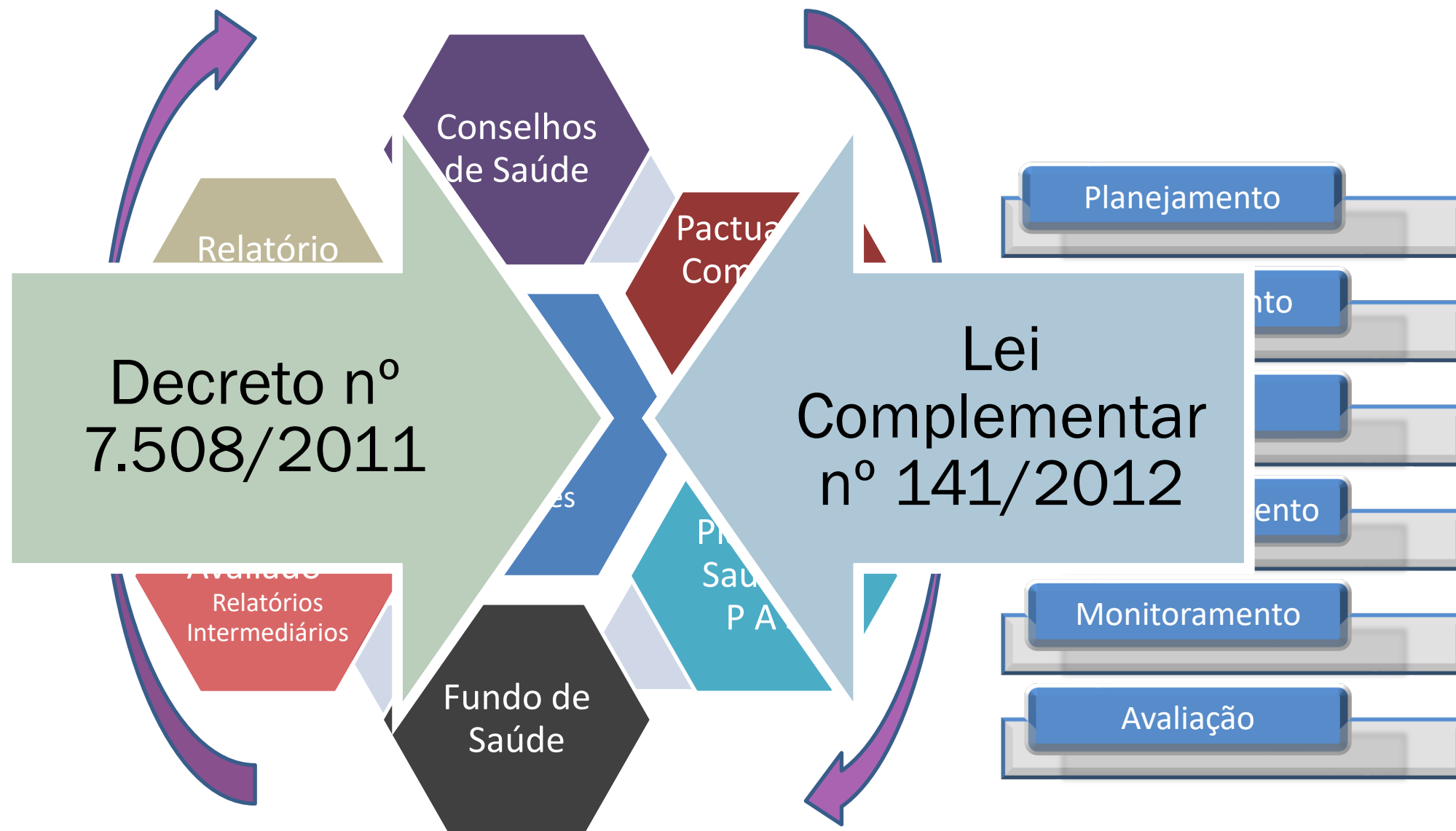
Transferências dos recursos para contas correntes específicas dos Fundos Estaduais/Distrital de Saúde, e transferências de recursos *fundo a fundo* para os Fundos de Saúde dos Municípios em contas correntes específicas.

Transferências em contas correntes específicas dos Fundos de Saúde Municipais.

Ciclo de Gestão



Ciclo de Gestão





3

FINANCIAMENTO DO SUS

Dados do IBGE de 2019 estimam que no Brasil o consumo de bens e serviços de saúde foi da ordem de 9,6% do Produto Interno Bruto (PIB), sendo que apenas 3,8% são gastos públicos. Quando comparados a países com sistemas universais de saúde, observa-se que no Brasil os gastos públicos são muito inferiores aos gastos privados.

A Emenda Constitucional (EC) n. 95, de 2016, agravou o subfinanciamento do SUS, ao estabelecer por 20 anos, um teto de gastos federal corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do ano anterior, o que consolidou a participação dos recursos orçamentários federais a apenas 1,7 % do PIB. "O congelamento do piso federal de aplicação de recursos em saúde pela EC n. 95 retirou quase R\$ 37 bilhões do SUS entre 2018 e 2022, em comparação com a regra anterior" *apud* (Nova Política de Financiamento do SUS: Concepções e Diretrizes, ABRES/2022).

O enfraquecimento do SUS, decorrente da redução progressiva no financiamento federal, tem levado famílias a terem que gastar mais recursos do próprio bolso para acessar serviços privados de saúde em situações de emergência (gasto catastrófico). Além de agravar o empobrecimento da população, piorando a economia brasileira, esse fenômeno deteriora a situação de saúde e aumenta as inequidades no país.

PROPOSTAS

- ▲ Revogar a EC n. 95;
- ▲ Contemplar um crescimento progressivo do orçamento do Ministério da Saúde, passando dos atuais 1,7% para 2,9% do PIB em gasto público federal em saúde até o ano de 2026, totalizando 5% do PIB, com vistas a alcançar a meta de 6% no plano decenal, conforme definido pela OPAS/OMS para os países da região das Américas.

Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Aplicar os recursos recebidos seguindo as normas aplicáveis à administração pública quanto a despesa e a receita, de acordo com a política de saúde estabelecida no planejamento.

Orçamento Público

Estima Receita

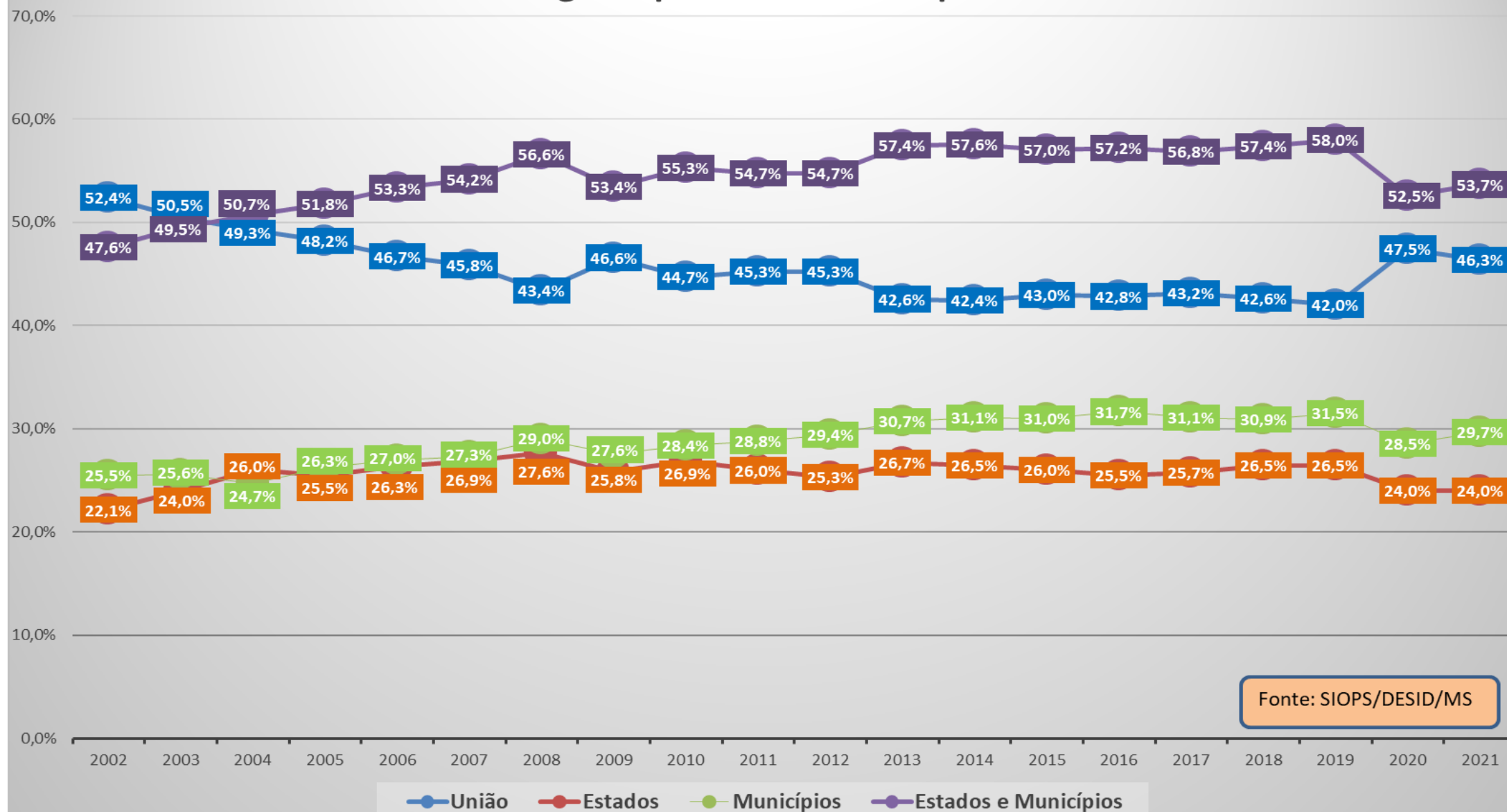
- ✓ Arrecadação
- ✓ Superávit
- ✓ Frustação
- ✓ Fonte
- ✓ Vinculação



Fixa Despesa

- ✓ Execução
- ✓ Empenho
- ✓ Restos a Pagar
- ✓ Vinculação
- ✓ Fonte
- ✓ Categoria Econômica
- ✓ Contingenciamento

Dimensionamento do gasto público em ASPS por esfera - 2002 a 2021



Fonte: SIOPS/DESID/MS

ASPS

VI gasto acima do Mínimo Constitucional - em R\$ Bilhões	2021	2022	% de Variação
Estados/DF	11,4	16,7	46%
Municípios	40,0	47,7	19%
Total	51,4	64,4	25%

Fonte: SIOPS/MS

Saldo em contas correntes federais - em R\$ Bilhões	2021	2022	% de Variação
Estados/DF	9,9	10,2	3%
Municípios	16,9	15,4	-9%
Total	26,8	25,6	-4%

Fonte: FNS/MS

Recursos transferidos pelo FNS - em R\$ Bilhões	2021	2022	% de Variação
Estados/DF	27,4	23,2	-15%
Municípios	78,0	77,9	-0,1%
Total	105,4	101,1	-4%

Fonte: FNS/MS

Comparativos

	Fundos Estaduais de Saúde			Fundos Municipais de Saúde			Totais dos Fundos de Saúde		
Exercício	Saldos em c/c	Repasses Recebidos	% Teorico de Execução Financeira	Saldos em c/c	Repasses Recebidos	% Teorico de Execução Financeira	Saldos em c/c	Repasses Recebidos	% Teorico de Execução Financeira
2019	R\$ 4,4	R\$ 21,4	79,5%	R\$ 11,4	R\$ 63,2	82,0%	R\$ 15,7	R\$ 84,6	81,4%
2020	R\$ 9,4	R\$ 29,8	68,4%	R\$ 14,3	R\$ 85,4	83,3%	R\$ 23,7	R\$ 115,2	79,4%
2021	R\$ 9,9	R\$ 27,4	63,9%	R\$ 16,9	R\$ 78,0	78,3%	R\$ 26,8	R\$ 105,4	74,6%
2022	R\$ 10,2	R\$ 23,2	56,1%	R\$ 15,4	R\$ 77,9	80,2%	R\$ 25,6	R\$ 101,1	74,6%

Valores em R\$ bilhões

Reflete posição de 31/12 de cada ano

Somatório dos saldos das contas correntes federais

Valores não refletem os Restos a Pagar

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2023/03/estados-e-municipios-acumulam-bilhoes-parados-em-fundos-de-saude.shtml?utm_source=sharenativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo

13/03/2023

Operacionalização da LC nº 197 de 6/12/2022 e da Pt GM/MS nº 96 de 07/02/2023

Contas correntes federais anteriores a 2018			
Esfera	Qtde c/c	Saldos Existentes em R\$	Valores em R\$ EPSFL Pt nº 96/2023
Estadual	1.668	693.288.456	772.063.833
Municipal	65.496	1.426.893.464	1.227.936.167
Total	67.164	2.120.181.920	2.000.000.000

Saldo Existentes em 31/12/2022 - portalfns.saude.gov.br

Contas Correntes Pt 3.992/2017	Quantidade	nº vezes
Estados/DF	54	30,9
Municípios	11.136	5,9
Total	11.190	6,0

Formas de Financiamento no SUS

FORMAS DE FINANCIAMENTO	FAVORECIDOS	Norma Aplicável
Transferências Fundo a Fundo	Fundos de Saúde	LC nº 141 de 13/01/2012
Convênios	Fundos Estaduais e Municipais*, EPSFL (CNES - CEBAS)	Decreto nº 8.180 de 30/12/2013
Contrato de Repasse (Construção Civil)	Fundos de Saúde(construção, ampliação e reforma, EPSFL (reforma)	
Termo de Execução Descentralizada - TED	Instituições Federais de Serviços de Saúde (CNES)	

* Parágrafo Único, Art. 18 da LC nº 141/2012

Transferência Regular e Automática Fundo a Fundo

É a transferência de recursos realizada entre fundos de saúde regularmente, independente de convênios ou instrumentos congêneres.

Para efeito da Lei Complementar nº 141/2012, é vedada, nessa modalidade de transferência, a exigência de restrição à entrega dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, sendo esses recursos considerados **transferências obrigatórias**, **porém** podendo a sua entrega estar condicionada à instituição e ao funcionamento do Fundo de Saúde, do Conselho de Saúde e elaboração do Plano de Saúde (Art. 22).

Para não mais confundir!!



<i>Transferências por:</i>		
	<i>Fundo a Fundo</i>	<i>Convênio</i>
Base Legal:	Lei Complementar nº 141/2012;	Decreto nº 6.170/2007 e alterações;
Favorecidos:	Fundos de Saúde dos Entes Subnacionais;	Fundos de Saúde dos Entes Subnacionais; Entidades privadas sem fins lucrativos;
Condições:	Fundo de Saúde e Conselho de Saúde instituído e em funcionamento; Elaboração do Plano de Saúde;	Estar habilitado conforme normas vigentes. Vide Cartilha para Apresentação de Propostas ao MS 2022, item 3.4 – link: https://portalfns.saude.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/CARTILHA_2022_livro.pdf ;
Características:	Ações continuadas; conta bancária única por Bloco de Financiamento;	Projetos específicos; contas bancárias individualizadas;
Comprovação do gasto:	RREO-relatório resumido de execução orçamentária quadrimestral, RAG- relatório anual de gestão;	PC-prestação de contas e RAG-relatório de gestão;
Prazo de envio comprovações:	RREO – em maio, setembro e fevereiro de cada exercício; RAG - até 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira;	Conforme normas específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos; É fixada no instrumento de repasse;
Aprovação dos Relatórios:	Conselho de Saúde do Ente Subnacional, Casa Legislativa do Ente Subnacional.	Ministério da Saúde.

IMPORTANTE

- ✓ as despesas com ações e serviços públicos realizadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde (parágrafo único, Art. 2º, LC 141/2012);
- ✓ os recursos da União serão transferidos aos demais entes da Federação e movimentados até a sua destinação final em contas específicas mantidas em instituição financeira oficial federal (§ 2º Art. 13, LC 141/2012);
- ✓ os Fundos de Saúde devem ser instituídos por lei e mantidos em funcionamento pela administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituindo-se em unidades orçamentárias e gestoras dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde. (Art. 14, LC 141/2012);

Natureza Jurídica – IN RFB nº 2.119 de 06/12/2022
Fundo Público da Administração Direta
Federal – 131-7
Estadual ou do DF – 132-5
Municipal – 133-3

Algumas dificuldades observadas ao longo do tempo na gestão dos recursos, a serem comprovadas:

- as portarias do Ministério da Saúde deixam dúvidas quanto às orientações de mérito e utilização dos recursos, além de que as ações orçamentárias estabelecidas nas diversas leis orçamentárias nem sempre apresentam correlação;
- os recursos transferidos aos entes subnacionais, na modalidade fundo a fundo, muitas vezes são interpretados e normatizados como instrumento de convênios, em que pese as atividades continuadas não poderem ser financiadas por meio desse instrumento;
- pouca atenção para a compatibilidade entre os resultados da execução orçamentária e as metas físicas estabelecidas em instrumentos de planejamento;
- complexidade normativa das questões fiscais, orçamentárias e contábeis, além do que tais normas podem não ser compatíveis entre si, causando seu eventual descumprimento;

Algumas dificuldades observadas ao longo do tempo na gestão dos recursos, a serem comprovadas:

- interferências de secretários de finanças/fazenda/economia na gestão financeira da saúde;
- falta de prioridade nas compras específicas de insumos para a saúde em função de processos centralizados de compras sob responsabilidade de outras áreas de atuação que não a saúde;
- processos licitatórios morosos e complexos;
- dificuldade de compreensão do tema saúde no meio dos consultivos jurídicos dos entes;
- tempo dispendido para inclusão de recursos financeiros recebidos na lei orçamentária; e,
- a rotatividade excessiva da força de trabalho na atividade meio para tratamento de matérias essenciais para o planejamento, logística e execução orçamentária, financeira e contábil.

Pontos fundamentais!

- ❖ O secretário de saúde é, necessariamente, o patrocinador;
- ❖ Planejamento tem que seguir diretrizes;
- ❖ Orçamento tem que estar em consonância com o planejamento efetuado;
- ❖ Monitoramento e acompanhamento de metas físicas e orçamentárias tem que ser permanente;
- ❖ Ter conhecimento das ações da área de saúde;
- ❖ Ter conhecimento normativo compatível com o desempenho das atividades;
- ❖ Políticas Públicas na área da saúde têm que ser bem definidas.
- ❖ Estrutura física e operacional compatíveis com as atividades desenvolvidas.

Obrigado pela atenção



conass@conass.org.br



Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior – *Assessor Técnico*

Coordenador de Administração e de Finanças